

TEMA 1.10 • CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA

Trauma Cervical y Raquimedular

PERFIL EUNACOM 4.01.2.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Traumatismos Cervicales y Medulares

El trauma primario de la vía espinal y raquídea requiere sumo cuidado pre hospitalario para no convertir un daño anatómico leve en una sección medular total e irreversible (Tetraplejía alta o paraplejía baja), o una instauración masiva de **Shock Medular neurogénico** consecuente de la pérdida medular simpática (generando bradicardia relativa con vasodilatación paralítica hipovolémica masiva).

Epidemiología y Cinemática

La etiología primigenia mandatoria se origina casi en su totalidad tras los **Accidentes Automovilísticos de Alta Energía**, secundado posteriormente por caídas en picada desde grandes alturas.

Manejo Inicial

Sigue inexorablemente la norma inicial de resucitación primaria: 1. **A y B (Vía Aérea + Control Cervical Inmediato)**: Durante un choque masivo o alta energía, estabilizar la columna asume el primer plano. Es obligatoria la aplicación de **Collar Cervical Rígido y Tabla Espinal** de transporte desde el sitio del suceso hasta finalizar la comprobación radiológica hospitalaria o clínica rigurosa. 2. **C (Circulación y Tensión en Shock)**: Si aparece un claro componente de Shock Neurogénico o Medular periférico secundado a este trauma dorsal, se administrará Reanimación con volumen de suero vigorosa, seguido rápidamente por el uso fundamental de Drogas vasoactivas **Inotrópicas / Vasopresoras (Noradrenalina/Norepinefrina intravenosa)** para comprimir la caída global del lecho vascular muerto.

Evaluación Radiológica Espinal

¿Cuándo indicar estudios imagenológicos tomográficos obligatorios bajo sospecha clínica? Se exige obligatoriamente un **TAC Tomografía de Columna Cervical (o espinal global)** ante un impacto si cumplen alguna o varias: 1. Existencia en el instante de signos clínicos o déficits medulares sensitivo-motores presentes. 2. Antecedentes confirmados de un trauma violento de extrema energía o dolor referido localizado espinal de gran envergadura a un segmento palpable. 3. Incapacidad de realizar un chequeo mental íntegro (estado basal alcohólico, Glasgow deprimido, coma post-TCE, barrera idiomática insalvable).

• Alta Directa tras Extracción de Tabla Espinal:

- Si el accidentado carece de molestias cervicales espontáneas pre y durante la liberación paramédica y, mediante posterior palpación del explorador que presiona por cada segmento interespinoso de las vértebras resultando en **total ausencia de molestias dolorosas anatómicas palpatorias de los bordes óseos**, el cuello se encuentra y dictamina normal, libre de radiación. **NO requiere someterse al TAC y queda absuelto del collar.**

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Esguince Cervical por Latigazo Traumatismo inmensamente común producido por aceleración-desaceleración vial urbana de baja energía. - **Clínica Principal:** Dolorimiento cervical mecánico persistente o dolor somático nuchal muscular miofascial, **TOTALMENTE desprovisto de irradiaciones o de todo defecto sensitivo motor periférico limitante.** - **Manejo Investigativo:** Todo trauma cervical dudoso o latigazo que logue manifestar este "dolor", obliga como protocolo básico radiológico a la realización mínima referencial de una simple **Radiografía Lateral de Cuello** de chequeo base (evaluando rectificación de curvaturas o fracturas ínfimas ocultas indetectables que obligan a saltar al TAC). - **Tratamiento Focal del Lesionado:** Netamente sintomático y local. **AINEs** de acción analgésica potentes más interposición de un **Collar Cervical Blando** transitorio ortopédico cuyo uso radica y radica en descansar el lecho muscular antálgico contracturado pero no evita ninguna lesión estructural mecánica si esta última persistiera oculta.

Trauma Máxilo-Facial

- El piso mandibular central acarrea amenazas orgánico-vitales subyacentes, principalmente debido a riesgos como asfixia (colapso de estructuras al paladar faríngeo), compromiso de estigmas y afección neuro-craneana profunda.
- **Imagenología Central Eleccionaria:** Como todo examen traumatológico complejo subyacente masivo y óseo intracavitario irregular, la herramienta "Gold Standard" primaria es e incluye sistemáticamente el **TAC de Cara 3D / TAC Maxilofacial**. Ante la inminencia de un golpe craneal, se extenderá para descartar un TAC de encéfalo TCE asociado grave si abarca el reborde de la frente.
- **Estrategia y Manejo Quirúrgico Diferido Reconstructivo:**
- Ojeada clave que hay que tener presente en su actuar temporal. La inmensa mayoría de luxaciones o quebraduras estables del plano central (Fractura Nasal, Fracturas de Órbita complejas, Maxilar) **No se operan inmediatamente en base a horas ni de forma perentoria urgente de pabellón esa misma jornada**, con el fin expreso de salvaguardar del altísimo edema difuso que impide acoplar platinas maxilares o visualización perimetral exacta, optando por analgésicos fuertes y retrasando el quirófano para estabilizarse a la reducción definitiva hacia la ventana ideal de los **días 7 a 14 aproximadamente post-accidente.**

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Excepciones de Cirugía y Vía inmediata Urgente en Trauma Facial: 1. Aquellas estructuras que manifiestan salida de LCR rinolacrimatoria frontal y nasal post traumatismo agudo grave. 2. Sangrado Arterial imparable intrapalatal que exige cauterización local prioritaria y urgencia resolutive. 3. **FRACTURA MANDIBULAR BILATERAL GRAVE:** Este choque fractura y retrae radical y paralelamente el control anatómico del soporte ligamento glosal retrayendo asfícticamente a la totalidad masiva de la lengua contra el tubo faríngeo interrumpiendo abruptamente el calibre oxigenatorio. Conlleva una obligación primera paralela extrema de **Intubación Orotraqueal Urgente Temprana e inminente Cirugía Férula pre-maxilar.**

Laceraciones y Heridas Superficiales a Nivel Céfaló-Cauda Facial

- Existen ciertas aristas con las heridas periféricas en estuética capital del rostro y los pelos capilares craneano-mediales.
- **Microbiología del Territorio:** Puesto que el riego arterial colateral craneo-facial-tópico de la red es el más profuso masivo anatómico extenso que posee la geografía humana entera, los riesgos

inherentes purulentos y asépticos infecciosos bajan drásticamente de base natural y su pronóstico regerante local y biológico supera fácilmente al epitelio de otras regiones apéndiceanas extremidades a mismas patogénicas profundidades periciales de las cortadoras involucradas.

- - Como conclusión de su rica vascularidad profiláctica curativa, a las heridas puras y aseadas correctamente faciales o en cuero craneo-cabelludas expuestas **NO requieren de instalación de Antibióticos profilácticos masivos ni coberturas bacterianas extensas iniciales.**
- **Técnicas de Cierre Recomendado y Reconstrucciones Topográficas Estéticas:**
 - - **Laceración Cuero Cabelludo Intenso:** De alta frecuencia profusa en hemorragia y carentes por igual de interés visual del plano folicular re-poblable capilar, su cierre de base a elección consiste en la agilidad práctica mediante la adosación estéril de **Corchetes Mecánicos / Grapas a presión epiteliales**. No existe ninguna obligación preestablecida que dicte un rasurado pelicular universal capilar integral del cuero circundante para realizarlo al menos a primera instancia simple, salvo excepciones con fardos enjaranados.
 - - **Laceración y Herida Facial Estricta / Frente / Contornos:** Por su gran visualización exterior a largo plazo en su base regenerativa futura se recomiendan en pabellón básico externo **Suturas intradérmicas interiores** de base reabsorbible en total contraste de las ataduras tipo colchón pasacintas o las que anudan y presionan en las crestas perimetrales expuestas del material de seda para aminorar estigmas retráctiles de "corchetes de tren".
 - - **Laceraciones de Altísima Exigencia a Reconstrucción por Planos (Especialista en Pabellón Plástico General):** Obligatoriamente si involucran mutilaciones directas cortantes desfigurantes de gran impacto que asocian desunión de mucosas subyacentes críticas disjuntas, ej: disrupciones que cortan todo el espesor al través de los labios o párpados oftalmológicos, alas musculares de la nariz o cartílagos directos de las orejas/pabellón auditivo externo. Estos requieren obligatoria sutura estratificada por cada tipo de estrato individual y la reasignación de los milímetros perimetrales del cirujano plástico maxilofacial minucioso y competente. Suelen desamarrarse o

sacar hilos precozmente entre 5 y el 7mo día topográficamente si transcurrió de manera óptima por su rápido sello de cicatriz base.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito. Refiere dolor en el cuello pero está neurológicamente íntegro, sin déficit motor ni sensitivo. ¿Cuál es el examen mínimo inicial y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trauma Cervical y Raquimedular. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El trauma raquimedular puede causar tetraplejía si es cervical alto o paraplejía si es cervical bajo; el shock medular es vasodilatador y se trata con noradrenalina.
- El manejo inicial incluye ABC con collar cervical desde el inicio y tabla espinal para el traslado; el TAC de columna se pide solo si hay sospecha clínica.
- El esguince cervical presenta dolor sin déficit neurológico; como examen mínimo se pide radiografía lateral de cuello; tratamiento con AINEs y collar blando.
- El trauma maxilofacial tiene riesgo estético, de pérdida de vía aérea en fractura mandibular bilateral, y de daño cerebral; el examen de elección es el TAC de cara.
- La fractura mandibular bilateral obliga a intubación orotraqueal urgente por pérdida de la vía aérea.
- Las fracturas faciales pueden diferirse quirúrgicamente entre el día siete y catorce salvo complicaciones; las heridas de la cara rara vez se infectan y se suturan con técnica intradérmica.
- Las heridas del cuero cabelludo se suturan con grapas, no puntos, por el menor riesgo estético.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMA CERVICAL Y RAQUIMEDULAR)**PREGUNTA 1**

Un paciente de treinta años llega a urgencias tras un accidente de tránsito. Refiere dolor en el cuello pero está neurológicamente íntegro, sin déficit motor ni sensitivo. ¿Cuál es el examen mínimo inicial y el tratamiento?

- A)** TAC de columna cervical, collar rígido indefinido
- B)** Radiografía lateral de cuello, AINEs y collar blando temporal
- C)** Sin exámenes, solo AINEs y alta domiciliaria
- D)** Resonancia magnética de columna cervical, evaluación quirúrgica urgente
- E)** TAC de cerebro y cuello, hospitalización para observación

PREGUNTA 2

Un paciente politraumatizado llega a urgencias con accidente de tránsito de alta energía. Al examen presenta hipotensión, bradicardia y piel caliente. No tiene hemorragia visible. ¿Cuál es la causa más probable y el tratamiento?

- A)** Shock hipovolémico por hemorragia oculta, transfusión de sangre
- B)** Shock séptico, antibióticos de amplio espectro
- C)** Shock medular por sección medular, noradrenalina y suero fisiológico
- D)** Shock neurogénico por dolor, analgesia potente
- E)** Neumotórax a tensión, descompresión con aguja

PREGUNTA 3

Un paciente llega a urgencias con traumatismo facial grave. El examen revela fractura de ambas ramas mandibulares. ¿Cuál es la prioridad inmediata?

- A)** TAC de cara para confirmar la fractura antes de actuar
- B)** Intubación orotraqueal urgente
- C)** Cirugía diferida entre el día siete y catorce
- D)** AINEs y observación por ser fractura estable
- E)** Derivación a cirugía maxilofacial en los próximos días

RESUMEN: TRAUMA CERVICAL Y RAQUIMEDULAR

El trauma raquimedular tiene como principal riesgo el daño neurológico irreversible, ya sea tetraplejía si es cervical alto, o paraplejía si es cervical bajo o torácico. El shock medular ocurre por pérdida del tono simpático, con vasodilatación e hipotensión. Las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito y las caídas de altura. El manejo inicial es el ABC con collar cervical desde el inicio y tabla espinal para el traslado. El TAC de columna es obligatorio ante sospecha de trauma raquimedular: traumatismo de alta energía, déficit neurológico, shock medular o síntomas de fractura. Si el examen clínico es normal y no hay sospecha, no se pide el TAC. El shock medular se trata con noradrenalina y suero fisiológico. El esguince cervical o latigazo presenta dolor cervical sin déficit neurológico. Como mínimo se pide radiografía lateral de cuello. El TAC se pide si hay mayor sospecha de lesión. El tratamiento es AINEs e inmovilización transitoria con collar blando. El trauma maxilofacial tiene tres riesgos: estético, pérdida de vía aérea en fractura mandibular bilateral, y daño cerebral. El examen de elección es el TAC de cara. La cirugía puede diferirse entre el día siete y catorce. Las fracturas de cara, nasal y órbita pueden diferirse si no hay complicación. Las heridas faciales cicatrizan rápido y raramente se infectan; las del cuero cabelludo se suturan con grapas.